

Páciens neve: Horváth Áron
Taj-száma: 154 328 974
Születési dátum: 2005.03.15
Lakcím: 1082 Budapest,
Szentkirályi u. 4.

Nem: Férfi

Napi sorszám: 2

Beutaló orvos:26918

Beutaló egység: 4124536134
Toxikológia

Dátum: 2026. 04. 22.

Azon.: 0003325612

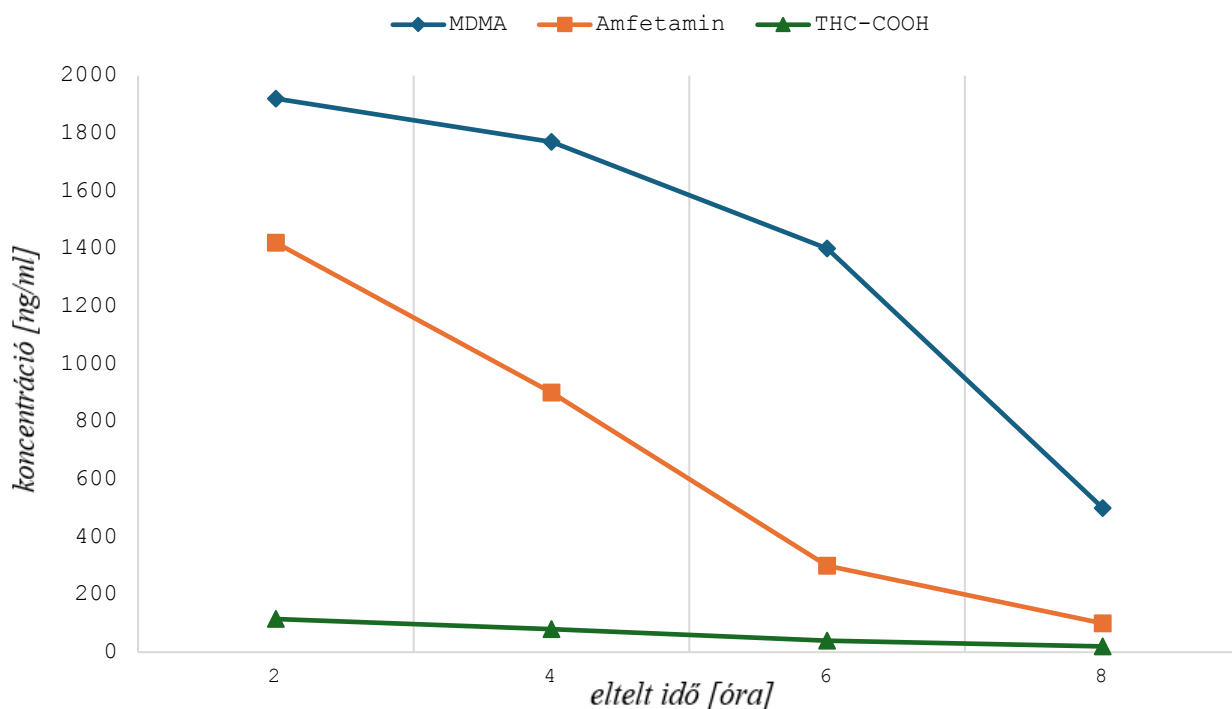
KLINIKAI KÉMIA ÉS HEMATOLÓGIA

Kért vizsgálatok:	Eredmény: mértékegység		Referencia érték:
WBC (Fehérvérsejt)	11,20	G/L	4,0 - 10,0 (H)
RBC (Vörösvérsejt)	5,10	T/L	4,5 - 5,9
Hemoglobin	158	g/L	135 - 175
Hematokrit	0,46	L/L	0,40 - 0,52
PLT (Trombocita)	210	G/L	150 - 400
Vércukor (éhom)	6,8	mmol/l	3,6 - 6,0 (H)
Nátrium	144	mmol/l	136 - 145
Kálium	3,9	mmol/l	3,5 - 5,1
Kreatin-kináz (CK)	485	U/L	40 - 190 (H)
S-Etanol (Véralkohol)	0,92	g/l	< 0,20 (Pozitív)
CRP (Gyulladásos marker)	4,2	mg/l	0,0 - 5,0

SÜRGŐSSÉGI TOXIKOLÓGIAI PANEL

A szűrés immunkémiai módszerrel történt

Kért vizsgálatok:	Eredmény: Mértékegység	Határérték
Amphetamine	1420 ng/ml	500 ng/ml
MDMA	1850 ng/ml	500 ng/ml
THC-COOH	115 ng/ml	50 ng/ml
Benzodiazepin	< 10 ng/ml	200 ng/ml
Cocaine Metabolite	< 50 ng/ml	300 ng/ml
Opioidok	< 100 ng/ml	2000 ng/ml
Methadone	< 25 ng/ml	300 ng/ml



ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉS

A laboratóriumi paraméterek és a klinikai kép alapján a páciens állapota akut intoxikációnak felel meg. A stimulánsok jelenléte magyarázza a felvételnél észlelt neurológiai és kardiális tüneteket.

Különös figyelmet érdemel a kiugró CK (Kreatin-kináz) érték, amely a tartós fizikai hyperaktivitás következtében kialakuló rhabdomyolysis gyanúját veti fel. Az emelkedett testhőmérséklet és az alacsony nátriumszint kritikus folyadékháztartási zavarra utal. A toxikus ágens és az alkohol együttes jelenléte fokozott kockázatot jelent a vese- és májfunkciókra.

Diagnózis:

- F19.1
- T43.6
- R50.9

Javaslat és további teendők:

A páciens kritikus állapota és a potenciálisan életveszélyes szövődmények kockázata miatt azonnali átszállítás indokolt az Intenzív Terápiás Osztályra. Az ellátás során folyamatos kardiális monitorozás, valamint emelt szintű, agresszív intravénás folyadékpótlás megkezdése szükséges. A veseelégtelenség megelőzése érdekében a vizeletmennyiség szoros követése, továbbá a pupillareflexek rendeződéséig tartó folyamatos neurológiai kontroll elengedhetetlen. A beteg állapotának stabilizálódását követően kötelező addiktológiai konzílium összehívása és a páciens szakirányú gondozásba vétele.